

CAPÍTULO 14.11

Artritis Juvenil Idiopática

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Enfermedad de Still** y la **Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)** de inicio **sistémico** representan en realidad la misma entidad fisiopatológica, diferenciándose principalmente por la edad de presentación del paciente.

Es fundamental no confundir esta patología con la **Artritis Reumatoide** clásica del adulto, ya que son enfermedades con mecanismos y comportamientos clínicos distintos.

TABLA 14.11.1: CARACTERÍSTICA VS ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (SISTÉMICA)

CARACTERÍSTICA	ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (SISTÉMICA)	ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO
Población	Niños (escolares y preescolares habitualmente)	Adultos
Fisiopatología	Idéntica	Idéntica
Manifestaciones	Sistémicas (Fiebre, Rash, Artritis)	Sistémicas (Fiebre, Rash, Artritis)

Clínica: La Tríada Clásica

El diagnóstico de esta enfermedad es eminentemente **clínico**. Aunque puede afectar a cualquier edad, es una causa importante de consulta en pediatría. La presentación clásica se compone de una tríada diagnóstica que debe buscarse dirigidamente:

- **Artritis:** Es el síntoma cardinal y requisito indispensable para el diagnóstico. Puede ser oligoarticular o poliarticular.
- **Fiebre:** Característicamente alta y en "picos" diarios. Es una de las causas más frecuentes de **Fiebre de Origen Desconocido (FOD)** en la edad pediátrica.
- **Rash Evanescente:** Es un exantema máculo-papular de color rosado (salmón), que aparece típicamente durante los episodios febriles y desaparece por completo cuando la temperatura normaliza.
- **Ubicación:** Tronco (especialmente costados del tórax) y zona proximal de las extremidades.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, ante un paciente pediátrico con **fiebre prolongada, artritis** y un **rash que aparece y desaparece con la fiebre**, la sospecha diagnóstica principal debe ser AIJ Sistémica (Enfermedad de Still).

Otros hallazgos clínicos

Además de la tríada, el paciente puede presentar: - **Adenopatías:** Inespecíficas pero frecuentes. - **Iridociclitis o Uveítis:** Al igual que otras enfermedades autoinmunes como las **Espondiloartropatías**, la **Enfermedad Inflamatoria Intestinal** o la **Enfermedad de Behçet**, esta patología puede comprometer el tracto uveal, requiriendo evaluación oftalmológica.

Diagnóstico y Marcadores de Laboratorio

No existe un marcador único y patognomónico (específico) para la Enfermedad de Still. El diagnóstico se apoya en la clínica y en la elevación de reactantes de fase aguda.

La Ferritina: El marcador clave

Aunque la **ferritina** se eleva en muchos procesos inflamatorios, en la Enfermedad de Still y la AIJ sistémica alcanza niveles desproporcionadamente altos. - Se considera un marcador de la **actividad de los macrófagos**. - Valores diagnósticos sugerentes: > **600 ng/ml**, pudiendo superar los **1000 ng/ml**.

NOTA CLÍNICA

La hiperferritinemia extrema es una pista diagnóstica fundamental. Si ves un caso clínico de artritis con ferritina sobre 1000, piensa inmediatamente en Still.

Otros hallazgos de laboratorio

- **Hemograma:** Es frecuente encontrar **leucocitosis** marcada con **neutrofilia** (predominio de neutrófilos). - **Reactantes de fase aguda:** Elevación de la Velocidad de Sedimentación Globular (VHS) y Proteína C Reactiva (PCR).

Algoritmo de Tratamiento

La mayoría de los casos tienen un buen pronóstico y responden bien al tratamiento inicial.

- **Primera Línea: AINEs**
- Son el pilar fundamental del tratamiento inicial.
- Se utilizan antiinflamatorios no esteroideos como el **naproxeno** (muy usado), **ibuprofeno** o **indometacina** por vía oral.
- En muchos pacientes, esto es suficiente para controlar la sintomatología.

2. **Segunda Línea: Corticoides y Biológicos** Si los AINEs fallan o los síntomas son muy graves, se debe escalar el tratamiento. **Corticoides:** Son efectivos pero se intenta limitar su uso, especialmente en niños, debido a sus múltiples efectos adversos (retraso del crecimiento, osteoporosis, etc.). * **Fármacos Biológicos:** Son la opción preferida actualmente si no hay respuesta a AINEs, con un perfil de acción similar a los usados en la **Artritis Reumatoide**, aunque su alto costo es una limitante.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En niños, el uso prolongado de corticoides es especialmente peligroso por el riesgo de supresión del eje y detención del crecimiento. Siempre se debe intentar la primera línea con AINEs antes de escalar.

Resumen para el EUNACOM

- **Fisiopatología:** Es una enfermedad inflamatoria sistémica. AIJ sistémica (niños) = Enfermedad de Still (adultos).
- **Clínica:** Fiebre alta intermitente + Rash asalmonado evanescente + Artritis.
- **Laboratorio:** Leucocitosis con neutrofilia y **Ferritina muy elevada** (>1000).
- **Tratamiento:**
 - 1. AINEs (Naproxeno).
 - 2. Biológicos o Corticoides (en casos refractarios).
- **Seguimiento:** Debe ser derivado al especialista (Reumatólogo infantil o de adultos) para manejo a largo plazo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 6 años con fiebre de 10 días, artritis de rodilla y rash macular eritematoso en tronco que aparece con la fiebre y desaparece al ceder. Ferritina 1200. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis Juvenil Idiopática. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- AJI = artritis reumatoide juvenil = enfermedad de Still del adulto (misma enfermedad a distintas edades)
- Tríada clásica: artritis + fiebre + rash evanescente (aparece con fiebre, desaparece al ceder)
- Es causa importante de fiebre de origen desconocido en pediatría
- Diagnóstico clínico; ferritina muy elevada (>600-1000) es marcador inespecífico
- Tratamiento primera línea: AINEs con excelente respuesta
- Segunda línea: biológicos (preferidos en niños) o corticoides

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS JUVENIL IDIOPÁTICA)

PREGUNTA 1

Niño de 6 años con fiebre de 10 días, artritis de rodilla y rash macular eritematoso en tronco que aparece con la fiebre y desaparece al ceder. Ferritina 1200. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Artritis séptica
- ☐ B) Artritis juvenil idiopática
- ☐ C) Lupus eritematoso sistémico infantil
- ☐ D) Enfermedad de Kawasaki
- ☐ E) Fiebre reumática

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la artritis juvenil idiopática?

- ☐ A) Corticoides en dosis altas
- ☐ B) Metotrexato semanal
- ☐ C) AINEs (ibuprofeno, naproxeno)
- ☐ D) Fármacos biológicos anti-TNF
- ☐ E) Hidroxicloroquina

PREGUNTA 3

Adulto de 30 años presenta artritis, fiebre y rash evanescente en tronco con ferritina muy elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Artritis reumatoide
- ☐ B) Lupus eritematoso sistémico
- ☐ C) Enfermedad de Still del adulto
- ☐ D) Dermatomiositis
- ☐ E) Artritis reactiva

RESUMEN: ARTRITIS JUVENIL IDIOPÁTICA

La artritis juvenil idiopática (AJI) es la misma enfermedad que la artritis reumatoide juvenil y que la enfermedad de Still del adulto, solo que a distintas edades. La tríada clásica es artritis, fiebre y rash evanescente (aparece con la fiebre y desaparece al ceder). El rash es macular eritematoso en tronco y extremidades proximales. Es una causa importante de fiebre de origen desconocido en pediatría. Puede asociarse a adenopatías e iridociclitis/uveítis. El diagnóstico es clínico; como marcador la ferritina se eleva mucho (>600-1000), y hay leucocitosis con neutrofilia, pero ambos son inespecíficos. El tratamiento de primera línea son AINEs (ibuprofeno, indometacina, naproxeno), con buena respuesta en la mayoría de los casos. De segunda línea están los fármacos biológicos, aunque por costo se usan corticoides (aceptables pero con muchos efectos adversos en niños).